

中焦脾胃为主,补阴阳应以下焦肾为主。

使用补法应注意:1. 补血滋阴的方药中应加入少量疏肝和胃之药,达补而不腻的目的。2. “大实有羸状”的真实假虚证,切忌用补法,以避免“误补益疾”。3. 邪盛正虚情况下,不可纯用补法,以防止“闭门留寇”。

(六)消法 是运用消散导滞的方药,以消除体内气滞、血瘀、食积等证的一种治疗大法。临床常用的消法有:1. 行气解郁,适用于气滞证,常用方剂如越鞠丸等。2. 活血化瘀,适用于血瘀证,常用方剂如血府逐瘀汤等。3. 消食导滞,适用于胃肠积滞,常用方剂如曲麦散等。

消法虽较下法缓和,但过度使用亦可使病畜气血耗损,故用于孕畜和弱畜时,应适当作以补养药,并掌握好用量。

(七)和法 又称和解法,是运用具有疏通调和作用的方药,以祛除病邪、扶助正气的一种治疗大法。本法主要适用于半表半里的少阳证和肝脾不和的腹痛、泄泻等症,前者以小柴胡汤为代表方剂,后者以痛泻要方为代表方剂。

使用和法应注意:1. 凡邪在表,未入少阳,或邪已入里,阳明热盛者,均不宜使用和法。2. 病属阴寒,见有耳鼻俱凉,四肢厥逆者,禁用和法。

(八)吐法 是应用具有涌吐作用的药物,引导病邪或有毒物质从口吐出的一种治法。本法主要适用于误食毒物、痰涎壅盛、食积胃脘等病证。吐法是一种急救的方法,多用于病情紧急而严重时。用之得当收效迅速,用之不当易伤正气,所以使用吐法应特别谨慎。如非急症,只是一般积食、痰积等,尽可能用化痰、导滞的方法。

吐法在兽医临床上主要用于小动物,大动物则很少运用,使用时应注意,心衰体弱,怀孕及产后,失血过多的患畜均不宜用吐法。

以上治疗八法,各有其适应范围,但疾病发展到一定阶段常常会出现表里同病、虚实

夹杂等错综复杂的情况,此时,单用某一治法就难以奏效,需要将八法配合应用,以解除复杂的病变。临床常用的八法并用有温清并用、汗补并用,汗、下、清并用,消补并用等。

随着医学的发展和医疗实践的需要,临床上实际应用的治疗方法已不限于八法的范围,诸如运用收敛固涩的药物以达固涩滑脱的固涩法,运用通利小便的药物以排除水湿的利尿法,应用芳香辛烈的药物以达通窍开闭醒神的开窍法和应用镇静安神解痉作用的方药,以治疗心神不宁的镇潜法等等。总之,治法的正确运用有赖于正确的辨证。只有在辨证的基础上,针对病情的不同情况,立法选药,才可望获得良好的防治效果。

用中草药防治鸡法氏囊病

于正永(孟津县畜牧兽医站 471100)

随着畜牧业生产的发展,畜禽产品流通日益扩大,加之专业户从各地引鸡,致使1994年4—5月,在我县白合、朝阳等乡养鸡密集区暴发了鸡法氏囊病,给养鸡业带来巨大的经济损失。此病具有突发、传染快、病程短、死亡率高等急性症状。近二年我们用中草药对该病进行了防治,取得了满意的效果。

一、病情概述

发病多为20—40日龄的雏鸡,10日龄下和50日龄的也有少数发病。临床表现为羽毛蓬松,精神萎顿,畏寒打颤,食欲不振或废绝,病初体温升高,后降至常温,翅下垂,不原走动,拉白色水样稀粪,肛门处羽毛被粪污染。重者,鸡站立不稳,多伏卧或侧卧,以至瘫痪,后因脱水衰竭而亡。剖检可见法氏囊肿大2—3倍,浆膜水肿,大腿部肌肉严重出血,呈斑块状,胸肌呈弥漫性出血点,腺胃粘膜脱落,肠道有炎症的出血,脾、肾、胆囊、肝脏场肿大。

二、防治

初期曾用青链霉素、磺胺类药物及土霉素等药治无效,后改为中草药医治,效果甚佳。药方:板兰根、大青叶、公英各 450 克,黄柏、黄芩、二花、甘草各 250 克,石膏、藿香各 100 克,水煎二遍,药液约 10 公斤,可供 1000 只鸡防治,该鸡自饮,少数鸡不能自饮,可人工灌服,每只鸡 5—10 毫升,日服 3—4 次。

三、防治效果

采用本方预防此病,有效率可达 10%,当处共治病鸡 3470 只,治愈 3393 只,治愈率达 97.8%。一般服药后 4 小时即可见效,第二天即可控制死亡,服药 2—3 天病鸡即可痊愈,同群感染鸡亦不再发病。

四、讨论

1. 本病多发生 2—15 周龄的雏鸡,4—6 周龄鸡则最易感染,如不及时采取防治措施,即可很快蔓延全群,死亡率达 30% 左右。

2. 中草药防治鸡法氏囊病,具有疗效高、成本低、见效快、无副作用等特点,特别在当前疫苗效果不佳、又无有效药医治的情况下,采用中草药防治切实可行。

3. 92—93 年春,在我县部分乡村仍有法氏囊病发生,在相临村组据统计 7600 雏鸡在易发病前期饮服此药竟无一只发病,足以证明预防效果确实。

马属大肠宿粪病的治疗

贺延三(襄城县兽医院 452670)

大肠宿粪也属结症。结症是由于肠管运动和分泌机能减退,粪便停滞于某段肠管内,形成完全阻塞或不完全阻塞,引起的一种疝痛病,马属常有发生。

大肠宿粪在大肠结中占有一定比例,并容易误诊失治造成死亡。过去,见到这样病例时,使用泻剂攻之,其结果是有些病例只下

水不下粪,不能解决问题。近年来,采用大戟散治疗,共治疗十例,全部治愈。

处方:大戟 千斤子 木通 滑石 二丑 鼠粪 皂角 大黄 朴硝 青曲 此方来自《牛马经》

大肠宿粪的临床症状

1. 腹痛情况 疝痛不明显,只表现踢腿、伸腰、回头望腹或摇尾等轻微的腹痛现象,有的也起卧,多不滚转,常呈伸展状躺卧。

2. 大便情况 常见有稀粪排出,服用泻剂后,大量排出水样粪便,但有些病例只见下水不见下粪。

3. 肠音腹围情况 往往有肠音,但肠音不整,积粪区肠音低,其它区肠音不低,胀气不明显,腹围变化不大。

4. 肠道解剖情况 大肠中大量积粪,多达几十斤,积粪表面有一层光滑的粘膜层,药和水能从表面通过而不能渗入粪中去。

5. 其它情况 发病缓慢、病程长,可达十天左右,其间常有食欲,但不大吃,有饮欲,小便变化不大,口腔不太干燥,舌苔不厚,仅在舌面的沟纹中有绒毛样的舌苔。

6. 直检情况 肠道不干燥,可在某段肠管(大结肠或盲肠)触到大量积粪,硬度不大,指压有痕迹。其直检是确诊本病的主要依据。

病例介绍

1. 1994 年 11 月 13 日城关李庄胡岭的黄色公马,六岁口;中等膘,经常喂麦草。近几天因故没使役,喂过歇、歇过喂,却吃草减少。就诊:心跳、呼吸、体温正常,口腔不燥、津乏,腹围不太大,肠音左侧可以,右侧低弱,大便稀薄量小,每对时排粪一次,有时高抬后腿。直检:盲肠积粪,虽量大而不硬,判为宿粪性盲肠结。

治疗:大戟 30 克 千斤子 100 克
木通 10 克 滑石 60 克 二丑 100 克
大黄 100 克 芒硝 500 克 神曲 50 克
皂角 20 克 鼠粪半碗,下午 5 点灌